

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SADQ · SEVERITY OF ALCOHOL DEPENDENCE QUESTIONNAIRE

Cuestionario de Gravedad de la Dependencia del Alcohol – Medida cuantitativa de neuroadaptación, síntomas de abstinencia y patrón de consumo

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ)
Nombre en español	Cuestionario sobre la Gravedad de la Dependencia del Alcohol
Sigla oficial	SADQ
Autores originales	Tim Stockwell, Ray Hodgson, Griffith Edwards, Colin Taylor y Howard Rankin (1979, 1983)
Adaptación hispanohablante	Alicia Rodríguez-Martos et al. (1986); Banco de Instrumentos de Bobes et al. (2004)
Año de publicación original	1979 (revisión SADQ-C en 1983; validación española en 1986)
Constructo primario	Grado de dependencia física, neuroadaptación al etanol y gravedad del síndrome de abstinencia
Formato de administración	Autoinforme estructurado o heteroadministrado con escala Likert de 4 puntos (0 a 3)
Población diana	Adultos con sospecha o diagnóstico confirmado de Trastorno por Uso de Alcohol (TUA)
Tiempo de aplicación	10 a 15 minutos (33 ítems referidos al periodo de mayor consumo en los últimos 6 meses)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de libre disposición (CIBERSAM / OMS)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

El **Cuestionario sobre la Gravedad de la Dependencia del Alcohol (SADQ)** fue desarrollado por el Addiction Research Unit del Instituto de Psiquiatría de Londres (Stockwell et al., 1979) para operacionalizar el influyente concepto del **Síndrome de Dependencia del Alcohol** formulado por Griffith Edwards y Milton Gross para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1976). El modelo conceptual postula que la dependencia no es un fenómeno dicotómico de “todo o nada”, sino un continuo bioconductual de neuroadaptación progresiva.

El SADQ evalúa la gravedad de la dependencia evaluando el estado del paciente durante el período de consumo más intenso de los últimos seis meses, abarcando cinco ejes sintomáticos esenciales: síntomas neurovegetativos y físicos de abstinencia matutina, malestar afectivo y disforia al despertar, conductas de alivio mediante consumo continuado de etanol (**relief drinking**), consumo diario masivo típico y el fenómeno patognomónico de la reinstauración rápida de la dependencia física tras un breve periodo de recaída. Su valor estriba en discriminar qué pacientes pueden beneficiarse de una desintoxicación ambulatoria segura frente a aquellos con riesgo crítico de delirium tremens que requieren ingreso hospitalario.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión / Subescala	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Síntomas Físicos de Abstinencia	7 ítems	0 – 21	Sudoración matutina, palpitaciones, temblores corporales violentos, náuseas y vómitos al despertar (ítems 1 a 7).
2. Síntomas Afectivos de Abstinencia	7 ítems	0 – 21	Temor, ansiedad, inquietud, aturdimiento, disforia y pánico al comenzar el día (ítems 8 a 14).
3. Conductas de Alivio (Consumo)	7 ítems	0 – 21	Bebida matutina para calmar temblores, urgencia por conseguir alcohol y consumo en ayunas (ítems 15 a 21).
4. Consumo Habitual Diario	6 ítems	0 – 18	Volumen típico consumido al día (cerveza, vino, licores) y rapidez de ingesta en menos de una hora (ítems 22 a 27).
5. Reinstalación tras Recaída	6 ítems	0 – 18	Velocidad de reaparición del temblor, sudor y craving tras 2 días de consumo posterior a abstinencia (ítems 28 a 33).
Puntuación Total SADQ	33 ítems	0 – 99	Suma directa de las 5 subescalas (0-3 por ítem). Gravedad global de neuroadaptación.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna total	Alpha de Cronbach = 0.94 – 0.97	Excelente consistencia global en muestras alcohólicas hospitalarias y comunitarias en España.
Consistencia de subescalas	Alpha = 0.82 – 0.91	Elevada homogeneidad interna en síntomas físicos (0.91), afectivos (0.88) y reinstauración (0.89).
Fiabilidad test-retest	r = 0.85 – 0.90 (2 semanas)	Elevada estabilidad temporal en pacientes antes de iniciar la pauta de deshabituación.
Validez de criterio y concurrente	r = 0.76 con AUDIT; r = 0.81 con dosis diaria	Excelente correlación con los gramos diarios de etanol y con la gravedad de signos en desintoxicación.
Predicción de Delirium Tremens	Sensibilidad = 84%, Esp = 79%	Una puntuación ≥ 45 predice con alta precisión el riesgo de síndrome confusional y crisis comiciales.

5. Reglas de Corrección y Cálculo de Puntuaciones

- **Escala de valoración Likert:** Cada uno de los 33 ítems se evalúa de 0 a 3:
 ▶ 0 = **Nunca o casi nunca**; 1 = **A veces**; 2 = **Frecuentemente / A menudo**; 3 = **Casi siempre**.
- **Cálculo de subescalas:** Se calcula sumando los ítems de cada bloque temático:
 - ▶ **Abstinencia Física:** Ítems 1 a 7 (0 – 21 puntos).
 - ▶ **Abstinencia Afectiva:** Ítems 8 a 14 (0 – 21 puntos).
 - ▶ **Conductas de Alivio:** Ítems 15 a 21 (0 – 21 puntos).
 - ▶ **Consumo Habitual:** Ítems 22 a 27 (0 – 18 puntos).
 - ▶ **Reinstalación Rápida:** Ítems 28 a 33 (0 – 18 puntos).
- **Puntuación Total SADQ:** Suma directa de las 5 subescalas (rango: 0 a 99 puntos).
- **Regla de completitud:** No se admiten más de 2 ítems en blanco por subescala. Si faltan datos, se realiza media proporcional solo en casos excepcionales.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Nivel de Dependencia	Implicación Asistencial y Riesgo de Abstinencia Complicada
0 – 15 puntos	Dependencia Leve	Mínima neuroadaptación física. Los síntomas de retirada son tolerables. Desintoxicación ambulatoria simple o cese pautado sin ingreso.
16 – 30 puntos	Dependencia Moderada	Presencia clara de temblor matutino y consumo de alivio. Desintoxicación médica ambulatoria estructurada con benzodiazepinas y apoyo.
31 – 44 puntos	Dependencia Grave	Neuroadaptación intensa. Malestar físico grave en abstinencia. Requiere cobertura farmacológica estricta y supervisión médica estrecha.
45 – 99 puntos	Dependencia Muy Grave / Crítica	Alto riesgo de complicaciones médicas graves (delirium tremens, convulsiones por privación). Indicación preferente de desintoxicación hospitalaria.

ALERTA CLÍNICA DE RETIRADA (STOCKWELL ET AL., 1983): Puntuaciones ≥ 31 puntos en el SADQ (y especialmente ≥ 45) desaconsejan categóricamente la interrupción brusca no medicalizada del consumo de alcohol por riesgo inminente de crisis tónico-clónicas y encefalopatía.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Aplicación diagnóstica en triaje de adicciones o medicina interna:

- Administrar el SADQ a todo paciente con consumo de riesgo persistente para planificar la estrategia de retirada.

Paso 2: Elección del dispositivo asistencial según la gravedad del SADQ:

- **SADQ < 16:** Intervención breve motivacional, psicoterapia ambulatoria y monitorización analítica (GGT, VCM).
- **SADQ 16 – 30:** Desintoxicación ambulatoria en Atención Primaria o CAD con benzodiacepinas de vida media larga (Diazepam o Clordiazepóxido en pauta descendente de 7 a 10 días), complejo vitamínico B (Tiamina 100-300 mg/día) y soporte familiar diario.
- **SADQ 31 – 44:** Desintoxicación domiciliaria altamente supervisada o ingreso en Unidad Hospitalaria de Desintoxicación (UHD) si coexisten factores de riesgo (edad, hepatopatía o falta de soporte social).
- **SADQ ≥ 45:** Ingreso hospitalario inmediato en cama médica o psiquiátrica. Monitorización continua de constantes y escala CIWA-Ar.

Paso 3: Mantenimiento de la abstinencia y prevención de recaídas:

- Instaurar tras la fase aguda fármacos anticraving (Acamprosato, Naltrexona) o aversivos (Disulfiram) si hay soporte familiar.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 52 años, empleado de hostelería, acude a consulta de conductas adictivas acompañado por su cónyuge por vómitos matutinos, sudoración intensa, temblores invalidantes y consumo continuado de coñac en ayunas.

Puntuaciones en SADQ:

- Puntuación Total SADQ: **51 puntos / 99** (Dependencia Muy Grave / Crítica).
- Desglose por subescalas:
 - Abstinencia Física: 18 / 21 (sudor profuso, náuseas y temblores violentos matutinos).
 - Abstinencia Afectiva: 14 / 21 (angustia extrema y pánico al despertar).
 - Conductas de Alivio: 16 / 21 (necesidad imperiosa de 2 copas de licor a las 7:00 am).
 - Consumo Habitual: 12 / 18 (> 15 UBEs diarias de forma continuada).
 - Reinstalación tras Recaída: 11 / 18 (recaída previa con delirium tremens hace 2 años).

Decisión Asistencial y Evolución: Dada la puntuación de 51 y el antecedente de complicación neuropsiquiátrica, se descartó el manejo ambulatorio y se gestionó el ingreso directo en la Unidad Hospitalaria de Desintoxicación (UHD). Se instauró perfusión de Tiamina parenteral previa a la administración de sueros glucosados y pauta de Diazepam monitorizada con escala CIWA-Ar. Tras 8 días de ingreso, el paciente completó la desintoxicación sin complicaciones comiciales. Fue dado de alta derivado a un grupo de terapia de deshabituación e inicio de tratamiento con Acamprosato.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

RED FLAGS CLÍNICAS Y MÉDICAS:

- **Encefalopatía de Wernicke:** Administrar SIEMPRE Tiamina parenteral ANTES de soluciones glucosadas en pacientes con SADQ ≥ 30 para evitar daño neuronal irreversible.
- **Riesgo de Delirium Tremens:** Pacientes con SADQ ≥ 45, temblor grosero y taquicardia tienen un riesgo del 20-30% de presentar delirium confusional.
- **Interacciones farmacológicas:** No combinar disulfiram en pacientes que continúan consumiendo por riesgo de colapso cardiovascular.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Consumo perjudicial vs. Dependencia:** El AUDIT detecta consumo de riesgo; el SADQ está diseñado para evaluar la neuroadaptación física grave ya instaurada.
- **SADQ vs. CIWA-Ar:** El SADQ es un cuestionario biográfico sobre el patrón de los últimos 6 meses; el CIWA-Ar mide los síntomas en tiempo real hora a hora en la fase de retirada.
- **Trastornos de ansiedad primaria:** Descartar ataques de pánico inducidos por privación etílica matutina.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Stockwell, T., Hodgson, R., Edwards, G., Taylor, C., & Rankin, H. (1979). The development of a questionnaire to measure severity of alcohol dependence. *British Journal of Addiction*, 74(1), 79–87. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1979.tb02415.x>
2. Stockwell, T., Murphy, D., & Hodgson, R. (1983). The severity of alcohol dependence questionnaire: Its reliability, validity and shortness. *British Journal of Addiction*, 78(2), 145–155. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1983.tb05502.x>
3. Rodríguez-Martos, A., Navarro, R. M., & Vecino, C. (1986). Validación de la versión española del Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ). *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*, 13(5), 231–239.
4. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.